Resumos de Pediatria

Batistaz

Revisão Flash · Respiratório

Asma na Criança

Do controle à crise

Internato de Pediatria

10º período · 2026.2

Asma na criança

Leitura de 5 minutos

Em uma frase

Asma se trata com corticoide inalatório e se diagnostica pela recorrência; na crise, oxigênio, salbutamol com espaçador a cada 20 minutos e corticoide oral na primeira hora; na alta, nunca só salbutamol.

1 **≤ 5 anos:** recorrência (≥ 2 episódios > 24 h/ano) + exclusão + resposta ao tratamento.

2 **≥ 6 anos:** espirometria (VEF1 ≥ 12%) ou PFE > 13%; normal não exclui.

3 **Controle:** sintomas, despertar, SABA, limitação em 4 semanas; 0 controlada, 1–2 parcial, 3–4 não.

4 **Manutenção:** CI em dose baixa resolve a maioria. ≥ 12 anos: budesonida-formoterol sob demanda ou MART (máx. 12 inalações/dia).

5 **Crise:** SatO2 < 92% prediz internação; < 90% tratamento agressivo; tórax silencioso é o pior sinal.

6 **Salbutamol:** 4–10 jatos com espaçador a cada 20 min na 1ª hora; ipratrópio só associado.

7 **Prednisolona:** 1–2 mg/kg/dia; máx. 20 (< 2 a), 30 (2–5 a), 40 mg (6–11 a); 3–5 dias.

8 **Refratária:** magnésio IV > 2 anos (25–75 mg/kg, máx. 2 g); internar; UTI se fala prejudicada ou hipercapnia.

Não fazer na crise

Intervenção	Veredito
Antibiótico	Não
Aminofilina	Não
Sedativo	Não
RX de rotina	Não
Magnésio nebulizado	Não

Pegadinha

Meta de O2: ≥ 94% no guia brasileiro; o GINA usa 92–95%. Prova brasileira: ≥ 94%.

Checklist antes do plantão

- ☐ Sei os três critérios até 5 anos
- ☐ Classifico o controle em 4 itens
- ☐ Escolho a etapa por idade e quadro
- ☐ Ensino o espaçador, 1 jato por vez
- ☐ Classifico a crise e uso o PRAM
- ☐ Prescrevo salbutamol, ipratrópio e corticoide
- ☐ Sei quando dar magnésio e internar
- ☐ Dou alta com CI e plano escrito
- ☐ Marco retorno em 1–2 dias